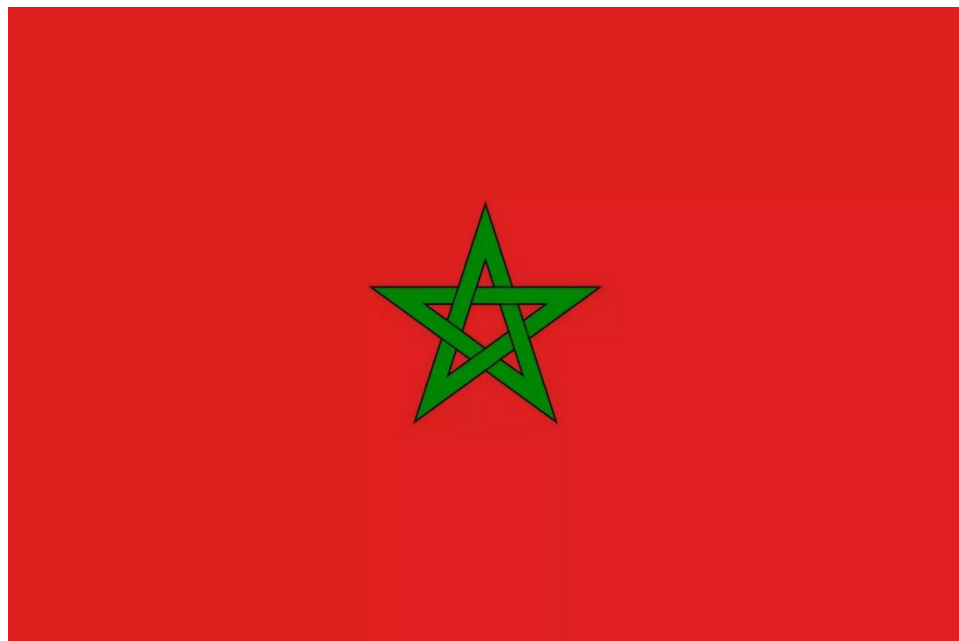


Concours



Epreuve Commune Nationale 03 Mars 2019

Avec Justification



[Lien Page Instagram](#)

**PRÉPA
CONCOURS
MSPS**



**OFFRE DE PRÉPARATION AU CONCOURS COMMUN
DE RECRUTEMENT- INSCRIPTION OUVERTE**

1) Les ressources humaines au Maroc sont caractérisées par :

- A) La densité médicale et paramédicale est de 1,64 pour 1000 habitants
- B) La norme internationale de densité des soignants selon l'OMS est 2 pour 1000 habitants
- C) Seulement 9 % des professionnels non médicaux sont des sages-femmes
- D) Les pédiatres et les gynécologues représentent 14% des cadres médicaux
- E) Toutes les propositions sont correctes

2) L'offre de soins est partiellement conditionnée par :

- A) La demande des professionnels
- B) Les besoins des professionnels
- C) L'environnement historique et actuel
- D) Les besoins de la population
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

3) Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les fonctions d'un système de santé sont :

- A) Réceptivité aux attentes de la population
- B) Protection contre les risques financiers et sociaux
- C) Ressources humaines
- D) Production des prestations de services
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

4) En pratique, il est considéré comme des substituts du lait maternel :

- A) Les laits artificiels maternisés
- B) Les tisanes, eaux minérales et jus
- C) Les aliments de compléments autorisés avant six mois
- D) Les biberons et tétines
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

5) La situation nutritionnelle au Maroc s'est améliorée grâce à trois facteurs :

- A) Le développement économique
- B) Le développement de l'éducation
- C) La régression du modèle alimentaire méditerranéen
- D) La promotion de l'activité physique
- E) L'amélioration des services de santé

6) En 2016, le ratio de mortalité maternelle au Maroc est de :

- A) 78 pour 100.000 naissances vivantes

- B) 75,2 pour 100.000 naissances vivantes
- C) 72,6 pour 100.000 naissances vivantes
- D) 71,2 pour 100.000 naissances vivantes
- E) 70,6 pour 100.000 naissances vivantes

7) Les déterminants de la santé ou de la maladie sont des facteurs :

- A) Biologiques
- B) Difficiles à être tous contrôlés par les systèmes de santé
- C) Liés à la politique générale d'un pays
- D) D'ordre psychosocial
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

8) La déclaration internationale d'Alma Ata faite en 1978 a concerné :

- A) Le renforcement des soins hospitaliers
- B) La promotion des soins de santé primaires
- C) La définition de la dimension qualité des soins
- D) La définition d'une politique internationale pour limiter les naissances
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

9) Le concept de « santé reproductive » :

- A) Concerne le bien social, physique et mental relatif à l'appareil génital chez la femme
- B) Est apparu la première fois en 1994 à la Conférence Internationale sur la Population et le Développement au Caire
- C) Intéresse seulement santé maternelle et infantile
- D) Parmi ses buts c'est d'assurer la liberté et la sécurité de se procréer
- E) La santé sexuelle est une de ses composantes essentielles

10) Selon l'OMS, le Code de commercialisation des substituts du lait maternel a pour but de :

- A) Interdire l'utilisation de substituts du lait maternel
- B) Protéger la pratique de l'allaitement maternel
- C) Promouvoir l'utilisation de substituts du lait maternel maternisés
- D) Interdire la publicité et le don gratuit d'échantillons
- E) Contrôler la qualité de ces produits notamment l'étiquetage

11) La stratégie nationale de nutrition 2011-2019 :

- A) S'inscrit dans les cibles mondiales de nutrition pour 2025
- B) Recommande de prévenir les carences en micronutriments

- C) Vise l'augmentation de l'allaitement maternel au moins à 50 %
- D) Contribue à la promotion de l'alimentation des adultes ayant des maladies chroniques
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

12) La mortalité maternelle est définie comme tout décès :

- A) Fortuit survenu au cours de grossesse
- B) Accidentellement survenu pendant les suites de couches
- C) Survenu au cours de la grossesse et ses suites par une cause aggravée ou liée
- D) Causé par des soins obstétricaux
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

13) Les principales causes de décès au Maroc sont :

- A) Les maladies infectieuses
- B) Les maladies de l'appareil circulatoire
- C) Les cancers
- D) La maternité
- E) Les maladies de l'appareil respiratoire

14) La stratégie nationale de la santé maternelle et néonatale a comme objectifs de réduire :

- A) La mortalité maternelle à 50 décès / 100.000 NV
- B) La mortalité infantile à 20 décès / 1000 NV
- C) La mortalité néonatale à 15 décès / 1000 NV
- D) La mortalité infanto-juvénile à 28 décès / 1000 NV
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

15) Les principales causes directes de mortalité maternelle au Maroc sont :

- A) L'hémorragie, l'éclampsie puis l'infection
- B) L'éclampsie, l'hémorragie puis l'infection
- C) L'hémorragie, l'éclampsie puis les avortements compliqués
- D) L'éclampsie, l'hémorragie puis les avortements compliqués
- E) Toutes les propositions précédentes sont fausses

16) Les principales causes directes de mortalité néonatale au Maroc sont :

- A) La prématurité, l'asphyxie et l'infection
- B) L'infection, le RCIU et l'asphyxie
- C) La prématurité et le faible poids de naissance

D) La prématurité et l'hypothyroïdie congénitale

E) La prématurité et la chorioamniotite

17) Les objectifs de l'économie de la santé sont :

A) Réduire les dépenses en santé

B) Contrôler les agents économiques

C) Optimiser l'utilisation des ressources

D) Proposer des solutions aux problèmes de financement de la santé

E) Assurer l'efficacité du système de santé

18) Parmi les sources de financement du système de santé au Maroc, on cite :

A) Recettes fiscales de l'État

B) La contribution directe des ménages

C) La coopération internationale

D) Le RAMED

E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

19) Le secteur public offre :

A) 68 % de la capacité litière hospitalière nationale

B) 55 % de la capacité litière hospitalière nationale

C) 50 % du personnel infirmier

D) 80 % des médecins

E) 60 % des médecins

20) Parmi les propositions suivantes, choisir les fonctions de l'hôpital :

A) Le développement professionnel

B) Gestion des productions

C) L'appui au réseau de soins de santé primaires

D) Le soin

E) Diagnostic

21) Le ratio établissement de soins de santé primaire par habitant est de :

A) 1 établissement pour 29.700 habitants

B) 1 établissement pour 21.000 habitants

C) 1 établissement pour 18.000 habitants

D) 1 établissement pour 15.000 habitants

E) 1 établissement pour 12.000 habitants

22) Le RAMED se fonde sur :

A) Le principe de l'assurance sociale au profit des ayant une activité lucrative

- B) Le principe d'assistance sociale au profit des démunis
- C) Seul le financement par l'État et les cotisations des bénéficiaires
- D) Le principe de solidarité nationale
- E) L'investissement pour se financer

23) Le Schéma Régional de l'Offre de Soins (SROS) est :

- A) Un moyen d'organisation et de projection de l'offre de soins
- B) Un outil de planification et de régulation de l'offre de soins au niveau régional
- C) Basé sur une approche globale, rationnelle, participative et équitable
- D) Élaboré par les services centraux du ministère de la santé et destiné aux régions sanitaires
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

24) Choisir les prestations offertes par le centre de santé rural de premier niveau :

- A) Les consultations de médecine générale
- B) Une permanence pour les urgences
- C) Le suivi des maladies chroniques
- D) Les médicaments de base
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

25) Le système de santé marocain se compose de :

- A) Secteur public et secteur privé
- B) Secteur public, secteur privé à but non lucratif et secteur privé à but lucratif
- C) Secteur public, secteur privé et traditionnel
- D) Installations de santé et établissements médico-sociaux
- E) Secteur de soins ambulatoire et hospitalier

26) Les stratégies de couverture pour répondre aux besoins de la population :

- A) Visites à domicile (VD)
- B) Unités médicales mobiles (UMM)
- C) Caravanes médicales spécialisées (CMS)
- D) Les fondations et associations œuvrant dans le secteur de la santé
- E) Hôpitaux mobiles (HM)

27) L'offre publique de soins est composée de quatre réseaux :

- A) Le réseau des établissements de soins de santé primaires (RESSP)
- B) Le réseau hospitalier (RH)
- C) Le réseau intégré des soins d'urgence médicale (RISUM)

D) Le réseau des établissements médico-sociaux (REMS)

E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

28) La santé communautaire est caractérisée par :

A) Les besoins sont déterminés par les professionnels de santé

B) La participation de la communauté à la gestion de la santé individuelle et collective

C) Le diagnostic communautaire

D) Débouche sur une politique de santé nationale

E) Où la population subit la décision nationale

29) Le taux des nouvelles infections par le VIH parmi les populations les plus exposées est :

A) 33 %

B) 43 %

C) 50 %

D) 67 %

E) 73 %

30) Actuellement, l'influenza H1N1 est un sous-type du virus de la grippe de :

A) A

B) B

C) Z

D) C

E) Aucune des propositions précédentes

31) En 2015, le taux d'occupation moyen des lits des hôpitaux marocains est :

A) 55 %

B) 63,8 %

C) 68,3 %

D) 71 %

E) 71 %

32) Le taux de couverture par le programme de planification familiale est :

A) 71,5 %

B) 69,3 %

C) 67,4 %

D) 63,0 %

E) 61,7 %

33) En 2016, l'indice synthétique de fécondité au Maroc est de :

- A) 1,1 enfant par femme
- B) 1,2 enfant par femme
- C) 2,2 enfants par femme
- D) 2,5 enfants par femme
- E) 2,7 enfants par femme

34) Le taux d'incidence de la tuberculose au Maroc est :

- A) 84 nouveaux épisodes pour 100.000 habitants
- B) 87 nouveaux épisodes pour 100.000 habitants
- C) 97 nouveaux épisodes pour 100.000 habitants
- D) 98 nouveaux épisodes pour 100.000 habitants
- E) 103 nouveaux épisodes pour 100.000 habitants

35) L'objectif général à l'an 2021 pour le contrôle et la prévention de la tuberculose est de réduire le nombre de décès liés à la tuberculose de :

- A) 75 % en 2021 par rapport à l'année 2015
- B) 50 % en 2021 par rapport à l'année 2015
- C) 40 % en 2021 par rapport à l'année 2015
- D) 45 % en 2021 par rapport à l'année 2010
- E) 40 % en 2021 par rapport à l'année 2000

36) Au Maroc, l'espérance de vie à la naissance est de :

- A) 76,9 ans
- B) 77,8 ans
- C) 78,6 ans
- D) 79,8 ans
- E) Aucune des propositions précédentes n'est juste

37) La prévalence du VIH/SIDA parmi la population générale est de :

- A) 0,1 %
- B) 0,8 %
- C) 0,01 %
- D) 0,08 %
- E) 0,03 %

38) Les objectifs du plan national de lutte contre le Sida 2017-2021 sont :

- A) Réduire les nouvelles infections par le VIH/SIDA de 75 %
- B) Réduire les nouvelles infections par le VIH/SIDA de 50 %



- C) Éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant
- D) Réduire le taux des cas au stade asymptomatique de 50 %
- E) Réduire la mortalité liée au VIH de 75 %

39) Parmi les populations suivantes, quelles sont celles à haut risque de complications de l'influenza H1N1 :

- A) Personnes âgées de plus de 60 ans
- B) Femmes enceintes
- C) Personnes atteintes de maladies chroniques
- D) Enfants âgés de moins de 5 ans
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

40) La vaccination antigrippale est une mesure préventive qui est recommandée pour :

- A) Toute la population
- B) Les femmes enceintes quel que soit l'âge de la grossesse
- C) Tous les enfants âgés de moins de 5 ans
- D) Les professionnels de la santé
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes



1) Les ressources humaines au Maroc sont caractérisées par :

- A) La densité médicale et paramédicale est de 1,64 pour 1000 habitants
- B) La norme internationale de densité des soignants selon l'OMS est 2 pour 1000 habitants
- C) Seulement 9 % des professionnels non médicaux sont des sages-femmes
- D) Les pédiatres et les gynécologues représentent 14% des cadres médicaux
- E) Toutes les propositions sont correctes

disposition de la population au personnel qualifié et suffisant.

Selon les normes de références fixées par l'OMS, le seuil critique de la densité médicale et paramédicale est de 2,5 personnels soignants pour 1000 habitants. Le Maroc ne dépasse guère 1,64 pour 1000 habitants.

2018

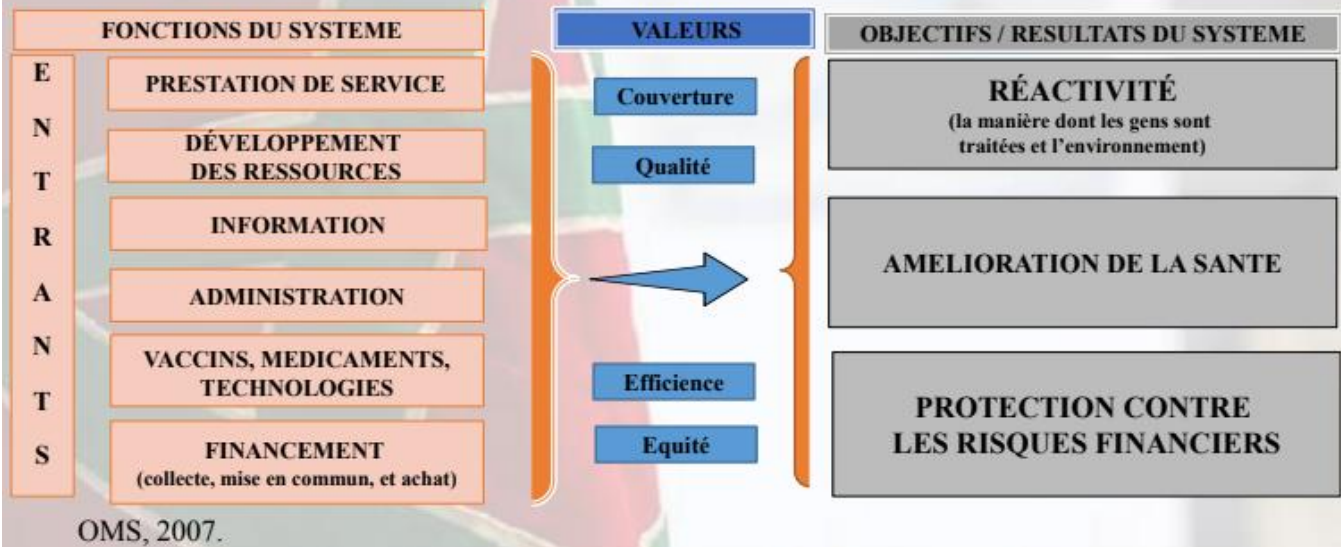
2) L'offre de soins est partiellement conditionnée par :

- A) La demande des professionnels
- B) Les besoins des professionnels
- C) L'environnement historique et actuel
- D) Les besoins de la population
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

3) Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les fonctions d'un système de santé sont :

- A) Réceptivité aux attentes de la population
- B) Protection contre les risques financiers et sociaux
- C) Ressources humaines
- D) Production des prestations de services
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

Les fonctions et objectifs d'un système de santé :



4) En pratique, il est considéré comme des substituts du lait maternel :

A) Les laits artificiels maternisés

B) Les tisanes, eaux minérales et jus

C) Les aliments de compléments autorisés avant six mois

D) Les biberons et tétines

E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

5) La situation nutritionnelle au Maroc s'est améliorée grâce à trois facteurs :

A) Le développement économique

B) Le développement de l'éducation

C) La régression du modèle alimentaire méditerranéen

D) La promotion de l'activité physique

E) L'amélioration des services de santé

6) En 2016, le ratio de mortalité maternelle au Maroc est de :

A) 78 pour 100.000 naissances vivantes

B) 75,2 pour 100.000 naissances vivantes

C) 72,6 pour 100.000 naissances vivantes

D) 71,2 pour 100.000 naissances vivantes

E) 70,6 pour 100.000 naissances vivantes

6. Mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)

Ratio de la mortalité maternelle

44.6

111.1

72.6

7) Les déterminants de la santé ou de la maladie sont des facteurs :

- A) Biologiques
- B) Difficiles à être tous contrôlés par les systèmes de santé
- C) Liés à la politique générale d'un pays
- D) D'ordre psychosocial
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

8) La déclaration internationale d'Alma Ata faite en 1978 a concerné :

- A) Le renforcement des soins hospitaliers
- B) La promotion des soins de santé primaires
- C) La définition de la dimension qualité des soins
- D) La définition d'une politique internationale pour limiter les naissances
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

https://www.cadtm.org/Declaration_Alma-Ata PDF :

Déclaration d'Alma-Ata

Déclaration d'Alma-Ata. La Conférence internationale sur les soins de santé primaires réunie à Alma-Ata ce douze septembre mil neuf cent soixante-dix-huit ...

9) Le concept de « santé reproductive » :

- A) Concerne le bien social, physique et mental relatif à l'appareil génital chez la femme
- B) Est apparu la première fois en 1994 à la Conférence Internationale sur la Population et le Développement au Caire
- C) Intéresse seulement santé maternelle et infantile
- D) Parmi ses buts c'est d'assurer la liberté et la sécurité de se procréer
- E) La santé sexuelle est une de ses composantes essentielles

10) Selon l'OMS, le Code de commercialisation des substituts du lait maternel a pour but de :

- A) Interdire l'utilisation de substituts du lait maternel
- B) Protéger la pratique de l'allaitement maternel



C) Promouvoir l'utilisation de substituts du lait maternel maternisés

D) Interdire la publicité et le don gratuit d'échantillons

E) Contrôler la qualité de ces produits notamment l'étiquetage

Article 1. But du Code

Le but du présent Code est de contribuer à procurer aux nourrissons une nutrition sûre et adéquate en protégeant et en encourageant l'allaitement au sein et en assurant une utilisation correcte des substituts du lait maternel, quand ceux-ci sont nécessaires, sur la base d'une information adéquate et au moyen d'une commercialisation et d'une distribution appropriées.

11) La stratégie nationale de nutrition 2011-2019 :

A) S'inscrit dans les cibles mondiales de nutrition pour 2025

B) Recommande de prévenir les carences en micronutriments

C) Vise l'augmentation de l'allaitement maternel au moins à 50 %

D) Contribue à la promotion de l'alimentation des adultes ayant des maladies chroniques

E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

Indicateurs	Valeur actuelle	Valeur 2012	Valeur 2019
Taux de pratique de la mise au sein précoce	52%	80%	90%
Prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans	10%	8%	5%
Allaitement maternel exclusif (0-6mois)	15%	50%	60%

D. Objectifs spécifiques :

1. Améliorer les indicateurs de l'état nutritionnel de la population tout au long du cycle de la vie ;
2. Promouvoir un mode de vie sain afin de prévenir les troubles nutritionnels et les maladies chroniques liées à la nutrition ;
3. Améliorer l'accessibilité des ménages aux produits alimentaires de qualité et en quantité suffisante ;
4. Renforcer les compétences institutionnelles et professionnelles en nutrition ;
5. Renforcer les mécanismes de coordination entre les différents intervenants en Nutrition ;
6. Développer la recherche et l'expertise en nutrition.

12) La mortalité maternelle est définie comme tout décès :

- A) Fortuit survenu au cours de grossesse
- B) Accidentellement survenu pendant les suites de couches
- C) Survenu au cours de la grossesse et ses suites par une cause aggravée ou liée
- D) Causé par des soins obstétricaux
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

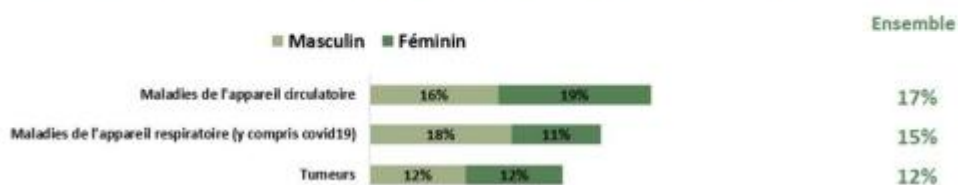
La mortalité maternelle correspond au décès d'une femme, survenu pendant la grossesse, l'accouchement ou dans les 42 jours suivant l'accouchement, dû à des causes liées à la grossesse, à sa gestion, ou à l'aggravation de pathologies existantes pendant la grossesse, à l'exclusion des causes accidentelles. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit ce décès comme lié à n'importe quelle cause aggravée par la grossesse ou sa prise en charge, mais non accidentelle. Ce phénomène est un indicateur important de la santé maternelle et de la performance du système de soins.



13) Les principales causes de décès au Maroc sont :

- A) Les maladies infectieuses
- B) Les maladies de l'appareil circulatoire
- C) Les cancers
- D) La maternité
- E) Les maladies de l'appareil respiratoire

Répartition des principales causes de décès (par chapitre), année 2020⁷



14) La stratégie nationale de la santé maternelle et néonatale a comme objectifs de réduire :

- A) La mortalité maternelle à 50 décès / 100.000 NV
- B) La mortalité infantile à 20 décès / 1000 NV
- C) La mortalité néonatale à 15 décès / 1000 NV

- D) La mortalité infanto-juvénile à 28 décès / 1000 NV
 E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

Il s'agirait au Maroc de réduire d'ici à 2030, le taux de mortalité maternelle à 36 décès pour 100 000 naissances vivantes et le taux de mortalité néonatale à 12 pour 1000 naissances vivantes.

Il s'agira également de réduire la disparité entre le milieu urbain et le milieu rural. En effet, le ratio de la mortalité maternelle s'élève à 111,1 décès maternels pour 100.000 NV pour le milieu rural contre 44,6 pour le milieu urbain.

Objectifs à l'horizon 2016

Ce plan d'action se fixe pour objectifs d'ici 2016 de :

- Réduire la mortalité maternelle de 112 à 50 décès pour 100 000 naissances vivantes ;
- Réduire la mortalité néonatale de 19 à 12 pour mille naissances vivantes.

Indicateur	Situation de référence 2011		Cible 2016	
	Ratio	Nbre	Ratio	Nbre
Mortalité maternelle	112 p. 100 000 NV	700	50 p. 100 000 NV	300
Mortalité infanto juvénile	30 p. 1000 NV	18000	20 p. 1000 NV	12000
Mortalité infantile	29 p. 1000 NV	17500	19 p. 1000 NV	11500
Mortalité néonatale	19 p. 1000 NV	11500	12 p. 1000 NV	6 500

15) Les principales causes directes de mortalité maternelle au Maroc sont :

- A) L'hémorragie, l'éclampsie puis l'infection
 B) L'éclampsie, l'hémorragie puis l'infection
 C) L'hémorragie, l'éclampsie puis les avortements compliqués
 D) L'éclampsie, l'hémorragie puis les avortements compliqués
 E) Toutes les propositions précédentes sont fausses

Les trois quarts des décès étaient de cause directe, 16% de cause indirecte et 10% non précisés. L'hémorragie est la première cause de décès (58%), suivie des maladies hypertensives (26%) puis les infections (8%).

16) Les principales causes directes de mortalité néonatale au Maroc sont :

- A) La prématurité, l'asphyxie et l'infection
- B) L'infection, le RCIU et l'asphyxie
- C) La prématurité et le faible poids de naissance**
- D) La prématurité et l'hypothyroïdie congénitale
- E) La prématurité et la chorioamniotite

17) Les objectifs de l'économie de la santé sont :

- A) Réduire les dépenses en santé
- B) Contrôler les agents économiques
- C) Optimiser l'utilisation des ressources**
- D) Proposer des solutions aux problèmes de financement de la santé**
- E) Assurer l'efficacité du système de santé

Economie de la santé: objectif

⊕ L'objectif de l'économie de la santé:

- ~~⊕ Faire des économies.~~
- ~~⊕ Diminuer les dépenses.~~
- ~~⊕ Contrôler les agents économiques.~~
- ⊕ Rechercher la meilleure utilisation des ressources.**

18) Parmi les sources de financement du système de santé au Maroc, on cite :

- A) Recettes fiscales de l'État
- B) La contribution directe des ménages
- C) La coopération internationale
- D) Le RAMED
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes**

Présentation des agrégats (Le financement de la dépense de santé)

👉 Se sont les ressources locales et externes

👉 Ressources locales:

- 📄 Impôts et recettes d'activités
- 📄 Sécurité sociale
- 📄 Mutuelles
- 📄 Assurances privées
- 📄 Paiement direct individuel

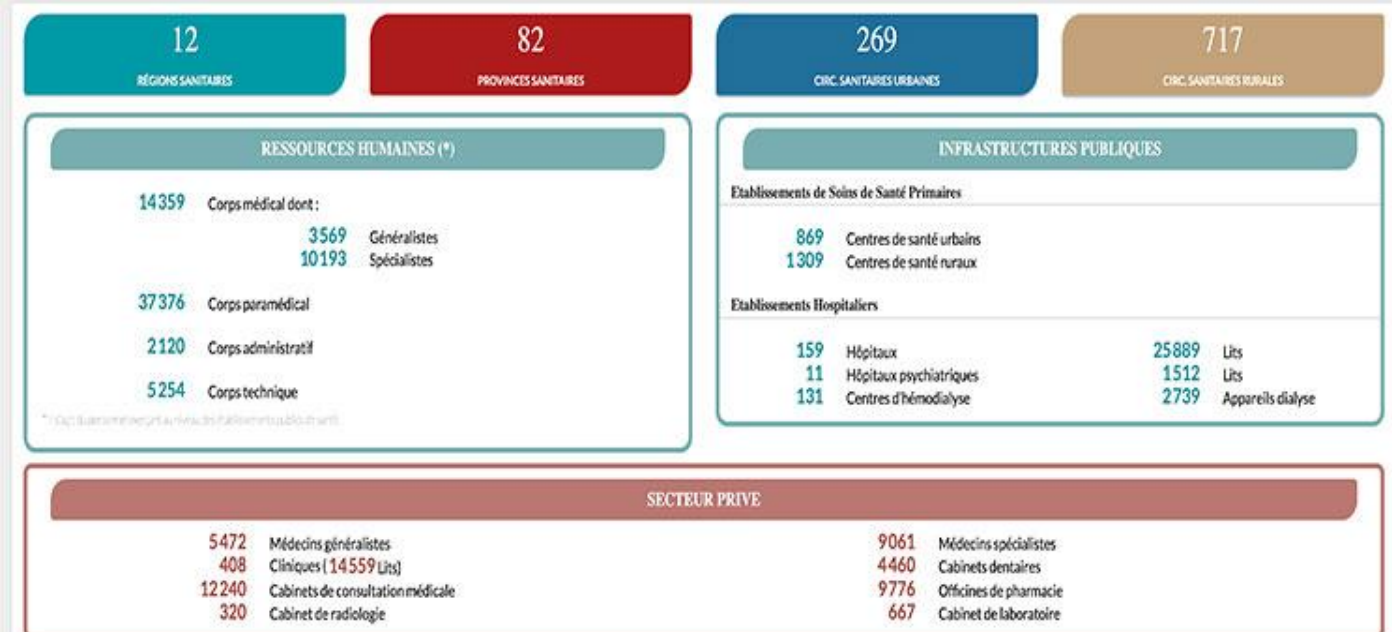
👉 Ressources externes:

- 📄 Dons : ONG, Coopération multilatérale ou bilatérale
- 📄 Prêts à taux bonifiés : Banque Mondiale, BAD
- 📄 Prêts à taux commercial, Prêts liés, Prêts avec conditionnalité

19) Le secteur public offre :

- A) 68 % de la capacité litière hospitalière nationale
- B) 55 % de la capacité litière hospitalière nationale
- C) 50 % du personnel infirmier
- D) 80 % des médecins
- E) 60 % des médecins

Chiffres clés de l'offre de soins



Pour une version interactive, veuillez utiliser votre navigateur Chrome



20) Parmi les propositions suivantes, choisir les fonctions de l'hôpital :

- A) Le développement professionnel
- B) Gestion des productions
- C) L'appui au réseau de soins de santé primaires
- D) Le soin
- E) Diagnostic

21) Le ratio établissement de soins de santé primaire par habitant est de :

- A) 1 établissement pour 29.700 habitants
- B) 1 établissement pour 21.000 habitants
- C) 1 établissement pour 18.000 habitants
- D) 1 établissement pour 15.000 habitants
- E) 1 établissement pour 12.000 habitants

Offre de soins, année 2023 ⁴

Habitants par ESSP	Habitants par lit hospitalier (secteur public)
12 300	1 364

22) Le RAMED se fonde sur :

- A) Le principe de l'assurance sociale au profit des ayant une activité lucrative
- B) Le principe d'assistance sociale au profit des démunis
- C) Seul le financement par l'État et les cotisations des bénéficiaires
- D) Le principe de solidarité nationale
- E) L'investissement pour se financer

23) Le Schéma Régional de l'Offre de Soins (SROS) est :

- A) Un moyen d'organisation et de projection de l'offre de soins
- B) Un outil de planification et de régulation de l'offre de soins au niveau régional
- C) Basé sur une approche globale, rationnelle, participative et équitable
- D) Élaboré par les services centraux du ministère de la santé et destiné aux régions sanitaires
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

24) Choisir les prestations offertes par le centre de santé rural de premier niveau :

- A) Les consultations de médecine générale
- B) Une permanence pour les urgences
- C) Le suivi des maladies chroniques
- D) Les médicaments de base
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

25) Le système de santé marocain se compose de :

- A) Secteur public et secteur privé
- B) Secteur public, secteur privé à but non lucratif et secteur privé à but lucratif
- C) Secteur public, secteur privé et traditionnel
- D) Installations de santé et établissements médico-sociaux
- E) Secteur de soins ambulatoire et hospitalier

26) Les stratégies de couverture pour répondre aux besoins de la population :

- A) Visites à domicile (VD)
- B) Unités médicales mobiles (UMM)
- C) Caravanes médicales spécialisées (CMS)
- D) Les fondations et associations œuvrant dans le secteur de la santé
- E) Hôpitaux mobiles (HM)

27) L'offre publique de soins est composée de quatre réseaux :

- A) Le réseau des établissements de soins de santé primaires (RESSP)
- B) Le réseau hospitalier (RH)
- C) Le réseau intégré des soins d'urgence médicale (RISUM)
- D) Le réseau des établissements médico-sociaux (REMS)
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

28) La santé communautaire est caractérisée par :

- A) Les besoins sont déterminés par les professionnels de santé
- B) La participation de la communauté à la gestion de la santé individuelle et collective
- C) Le diagnostic communautaire

D) Débouche sur une politique de santé nationale

E) Où la population subit la décision nationale

29) Le taux des nouvelles infections par le VIH parmi les populations les plus exposées est :

A) 33 %

B) 43 %

C) 50 %

D) 67 %

E) 73 %

30) Actuellement, l'influenza H1N1 est un sous-type du virus de la grippe de :

A) A

B) B

C) Z

D) C

E) Aucune des propositions précédentes

L'influenza H1N1 est une maladie respiratoire virale appartenant à la famille des virus de la grippe A, qui a été le sujet d'une pandémie mondiale en 2009

31) En 2015, le taux d'occupation moyen des lits des hôpitaux marocains est :

A) 55 %

B) 63,8 %

C) 68,3 %

D) 71 %

E) 71 %

32) Le taux de couverture par le programme de planification familiale est :

A) 71,5 %

B) 69,3 %

C) 67,4 %

D) 63,0 %

E) 61,7 %

33) En 2016, l'indice synthétique de fécondité au Maroc est de :

A) 1,1 enfant par femme

B) 1,2 enfant par femme

C) 2,2 enfants par femme

D) 2,5 enfants par femme

E) 2,7 enfants par femme

Indice synthétique de fécondité	2018	2,38
	2019	2,38
	2020	2,38
	2021	2,38
	2022	2,38
	2023	2,38

Nombre moyen
d'enfants par
femme

34) Le taux d'incidence de la tuberculose au Maroc est :

A) 84 nouveaux épisodes pour 100.000 habitants 2018

B) 87 nouveaux épisodes pour 100.000 habitants

C) 97 nouveaux épisodes pour 100.000 habitants

D) 98 nouveaux épisodes pour 100.000 habitants

E) 103 nouveaux épisodes pour 100.000 habitants

35) L'objectif général à l'an 2021 pour le contrôle et la prévention de la tuberculose est de réduire le nombre de décès liés à la tuberculose de :

A) 75 % en 2021 par rapport à l'année 2015

B) 50 % en 2021 par rapport à l'année 2015

C) 40 % en 2021 par rapport à l'année 2015

D) 45 % en 2021 par rapport à l'année 2010

E) 40 % en 2021 par rapport à l'année 2000

36) Au Maroc, l'espérance de vie à la naissance est de :

- A) 76,9 ans
- B) 77,8 ans
- C) 78,6 ans
- D) 79,8 ans
- E) Aucune des propositions précédentes n'est juste

Espérance de vie à la naissance, année 2023 ² (en année)

ENSEMBLE		HOMMES		FEMMES	
National	77,0	National	75,3	National	78,8
Urbain	78,7	Urbain	77,3	Urbain	80,2
Rural	73,8	Rural	71,8	Rural	75,9

37) La prévalence du VIH/SIDA parmi la population générale est de :

- A) 0,1 %
- B) 0,8 %
- C) 0,01 %
- D) 0,08 %
- E) 0,03 %

38) Les objectifs du plan national de lutte contre le Sida 2017–2021 sont :

- A) Réduire les nouvelles infections par le VIH/SIDA de 75 %
- B) Réduire les nouvelles infections par le VIH/SIDA de 50 %
- C) Éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant
- D) Réduire le taux des cas au stade asymptomatique de 50 %
- E) Réduire la mortalité liée au VIH de 75 %

BUT

Apporter une contribution effective et efficace, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale, pour mettre fin à l'épidémie de VIH d'ici 2030

OBJECTIFS

- Réduire de **75 %** les nouvelles infections par le VIH
- Éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant
- Réduire de **60 %** la mortalité liée au VIH,
- Réduire les barrières d'accès des PVVIH aux services de prévention, de prise en charge et d'appui, liées à la discrimination
- Renforcer la gouvernance pour une riposte efficiente

39) Parmi les populations suivantes, quelles sont celles à haut risque de complications de l'influenza H1N1 :

- A) Personnes âgées de plus de 60 ans
- B) Femmes enceintes
- C) Personnes atteintes de maladies chroniques
- D) Enfants âgés de moins de 5 ans
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

Épidémiologie

Toutes les tranches d'âge peuvent être touchées, mais certains groupes sont plus à risque.

- Les personnes les plus exposées au risque de maladie grave ou de complications lorsqu'elles sont infectées sont les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques (telles que les maladies cardiaques, pulmonaires, rénales, métaboliques, neurodéveloppementales, hépatiques ou hématologiques chroniques) et les personnes ayant des affections immunosuppressives ou suivant un traitement immunosuppresseur (personnes ayant contracté le VIH ou atteintes d'une tumeur maligne ou encore patients sous chimiothérapie ou traitement stéroïdien, par exemple).

40) La vaccination antigrippale est une mesure préventive qui est recommandée pour :

- A) Toute la population
- B) Les femmes enceintes quel que soit l'âge de la grossesse
- C) Tous les enfants âgés de moins de 5 ans
- D) Les professionnels de la santé
- E) Toutes les propositions précédentes sont correctes

Une vaccination annuelle est recommandée pour :

- les femmes enceintes ;
- les enfants âgés de 6 mois à 5 ans ;
- les plus de 65 ans ;
- les personnes atteintes de maladies chroniques ;
- les soignants.